Algoritmo CIF — Hombro

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Hombro. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. be450a25

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 2 si «SÍ»

2b La movilidad pasiva GH (sobre todo la RE) está limitada igual que la activa. ¿Hubo traumatismo previo?

- SÍ → 11 Luxación Bloqueada o Fractura (→ Rx)
- NO → 10 Artrosis Glenohumeral
- NO → 1 Capsulitis Adhesiva

→ sigue en el paso 3

SÍ

1 ¿El dolor se reproduce con movimientos cervicales, compresión axial o palpación de la primera costilla?

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL de la movilidad pasiva, especialmente en rotación externa?

SÍ Reproducción con movimientos cervicales (test de Spurling o similar)	→	6 Disfunción Cervical con Dolor Referido a Hombro
SÍ Restricción de movilidad en 1ª costilla y dolor en zona de transición	→	9 Disfunción de Primera Costilla (Zona Cervicotorácica)
NO No se reproduce con cervical ni 1ª costilla	→	sin hipótesis

SÍ Restricción global de la movilidad pasiva, con pérdida marcada de rotación externa	→	→ desvío 2b
NO Movilidad pasiva mayormente preservada	→	sin hipótesis

NO → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2 o del 2b

3 ¿El dolor está localizado en la parte superior (AC) o hubo un evento traumático con sensación de inestabilidad?

todas

4 ¿Hay dolor durante la elevación y/o déficits de fuerza?

Dolor en articulación acromioclavicular (parte superior)	→	7 Artropatía Acromioclavicular
Evento traumático / "Pop" con sensación de inestabilidad anterior	→	4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
Evento traumático / dolor profundo, síntomas de labrum (chasquidos)	→	5 Lesión Labral Superior (SLAP)
Episodio concreto o aprensión (inestabilidad anterior o posterior, también sin «pop» traumático)	→	4 Inestabilidad Glenohumeral (Anterior o Posterior)
Ninguno de los anteriores	→	sin hipótesis

Dolor al elevar el brazo o con los test resistidos, sin debilidad marcada ni signos de retraso	→	2 Síndrome de Pinzamiento Subacromial (Impingement)
Debilidad evidente caída del brazo (drop arm) o signos de retraso (lag signs)	→	3 Rotura del Manguito Rotador
Sin dolor claro ni debilidad en elevación	→	sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 5 ↓

↓ Paso 5: viene del paso 4

5 ¿Se observa asimetría o "winging" escapular durante el movimiento activo?

SÍ Asimetría visual en la elevación o test de asistencia escapular positivo	→	8 Discinesia Escapular
NO Sin alteración escapular evidente	→	sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de hombro inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0